

中山醫學大學附設醫院

主題名稱	胰臟癌 Pancreatic Cancer				
	編號	制定者	公布日期	修正日期	檢閱日期
	A31000-Q03-W-K26	緩和與林佩瑜	112 年 02 月 07 日	115 年 01 月 06 日	115 年 01 月 06 日
	護理部	核准者	吳姿蓉	修正日期	115 年 01 月 06 日
	第 1.2 版/7 頁	審查者	劉俞均	檢閱日期	115 年 01 月 06 日

一、目的

讓護理人員了解胰臟癌的定義、症狀、常見檢查、常見治療、護理問題與措施及衛教指導，有更適切之照護能力，提供最佳服務品質。

二、範圍

護理部各單位（含中興分院）。

三、說明

（一）定義

指胰臟細胞發生癌變而產生的腫瘤，其中以胰腺癌佔 90%以上，若為鱗狀上皮分化之腺鱗狀癌(adenosquamous carcinoma)，這種分型的預後極差。

（二）症狀

早期胰臟癌很難發現，臨床表現隨腫瘤侵襲的部位、大小及鄰近組織、器官的浸潤或壓迫而表現各異。最常侵犯胰臟頭部佔 70%，胰臟體部及尾部則各佔約 20%與 10%。上腹部及左側肋緣處鈍痛為最常見及最早出現的症狀，其次為體重減輕、噁心嘔吐、腸胃不適、新的或惡化的糖尿病，若侵犯膽道阻塞造成黃疸、可能伴有搔癢、尿液變深和大便灰白、腹水等，嚴重有出血的可能。

（三）常見檢查

- 1.腹部超音波(Abdominal echo)。
- 2.電腦斷層掃描(Computerized Tomography)。
- 3.磁振造影(MRI)。
- 4.內視鏡逆行性膽道胰臟攝影(Endoscopic Retrograde Cholangio-Pancreatography；

主題名稱	胰臟癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K26	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	2/7

ERCP)。

5.經皮穿肝膽道攝影(Percutaneous Transhepatic Cholangiography and Drainage ; PTCD)。

6.血液檢驗：CA-199 為相關癌症標記，數據高，可高度懷疑為胰臟癌，但有胰臟炎、肝硬化等情形時，亦可能超過正常值<35 U/mL。

(四) 常見治療

1.手術治療

外科治療是胰臟癌唯一治癒方法，但手術治療胰臟癌五年的存活率並不高。當胰臟體部及尾部有癌細胞浸潤時，或有轉移發生，則外科治療將有所限制。常見手術方式有胰臟十二指腸切除術(Pancreaticoduodenectomy)或惠普式手術法(Wipple's Procedures)、胰臟空腸切除術(Pancreaticojejunostomy)、膽管空腸切除術(Choledochojejunostomy)、胃空腸切除術(Gastrojejunostomy)。

2.非手術治療

(1) 化學治療：為晚期胰臟癌主要治療方式。

(2) 放射線治療：作為輔助療法。

(3) 標靶治療。

(4) 免疫治療：目前對胰臟癌治療效果有限。

3.藥物治療

(1) Gemcitabine

(2) TS-1

(3) FOLFIRINOX 療法

(4) Erlotinib (Tarceva™)

(5) Dialicon

(6) DMP

(7) Primperan

(8) Gascon

主題名稱	胰臟癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K26	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	3/7

(9) Urso

(五) 常見護理問題

1. 疼痛不適/與癌細胞侵犯或轉移有關
2. 體液容積太多/腫瘤轉移有關
3. 缺乏營養/少於身體所需
4. 心理靈性照護需求：如焦慮感受、感到無望、可能性哀傷反應、失去因應能力

(六) 護理措施

1. 疼痛不適/與癌細胞侵犯或轉移有關
 - (1) 監測疼痛性質、部位、特性及程度。
 - (2) 協助維持舒適的臥位。
 - (3) 給予適當的止痛劑。
 - (4) 教導透過非藥物之輔助療法及放鬆技巧，如：冷熱療法、芳香療法、穴位按摩等。
 - (5) 轉移注意力，如聆聽喜好音樂等。
2. 體液容積太多/腫瘤轉移有關
 - (1) 評估病人進食狀況並指導避免高鈉食品，如加工、醃製食品。
 - (2) 每日監測體重並告知體重變化情形。
 - (3) 協助床頭抬高 15 度，使其呼吸更順暢，並鼓勵病人做深呼吸，進而增進肺部的換氣量。
 - (4) 給予被動與主動的關節運動。
 - (5) 針對水腫部位提供適當的皮膚照顧。
 - (6) 若有腹水產生需監測腹圍變化。
 - (7) 依醫師指示限制水分攝取。
3. 缺乏營養/少於身體所需
 - (1) 監測病人進食狀況，有無噁心、嘔吐情形。
 - (2) 注意病人對飲食的耐受情形，必要時給予胰臟酵素，以促進消化。

主題名稱	胰臟癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K26	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	4/7

(3) 觀察體重變化、進食狀況，必要時給予適當靜脈輸液及腸胃道外全營養給液，以維持足夠的體液及電解質。

(4) 以高熱量、高蛋白及低脂飲食為主，鼓勵少量多餐並均衡營養攝取。

(5) 視病情監測血糖及給予胰島素使用相關衛教。

4. 心理靈性照護需求：如焦慮感受、感到無望、可能性哀傷反應、失去因應能力

(1) 先建立開放及信任的治療性關係，與病人有良好互動溝通。

(2) 與醫療團隊、病患及家屬共同進行病情討論，協助了解病情以增加自我控制感。

(3) 提供相關照顧資訊。

(4) 提供正向鼓勵、陪伴及不批判態度，促使病人分享內心感受。

(5) 引導表達對死亡看法，調適疾病變化面對死亡來臨。

(6) 協助生命回顧，提供專業知識、傾聽，感受病人想法與意義，提供適切護理，協助家屬調適悲傷情緒。

(七) 衛教指導

提供胰臟癌病人照護相關衛教指導：

1. 癌症疼痛

(1) 立即反應疼痛部位、程度、持續時間、型態。

(2) 按時服藥，切勿感到疼痛才吃。

(3) 冷熱敷、採舒適的臥位。

(4) 轉移注意力，如看電視、玩牌。

2. 癌症病人如何吃

(1) 食物選擇以質地柔軟為佳。

(2) 依病人喜好以少量多餐方式進食。

(3) 選擇新鮮蔬果。

(4) 高蛋白、高熱量飲食。

3. 內視鏡逆行性膽胰管攝影(ERCP)檢查前後衛教須知

主題名稱	胰臟癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K26	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	5/7

- (1) 檢查後須禁食 4 小時，以減少不適，並依醫師指示確認可以開始進食之時間，若醫囑可以進食時，需先喝水測試，若無不適才可進食。
- (2) 檢查後可能有噁心、嘔吐、腹痛、腹脹、發燒、感染等不適情形，若症狀持續請立刻告知醫護人員。
- (3) 有置放導管引流者，要注意活動時避免牽扯到導管。
- (4) 檢查時有使用鎮定劑者，檢查後需側躺及使用氧氣，避免影響呼吸功能。

4. 腹腔放液術

- (1) 每次放液總量由醫師評估，若量過多或速度過快，會使腹腔內壓力迅速下降，導致血管擴張，產生休克情形。
- (2) 注意引流液量、顏色、性質，勿拉扯管路。
- (3) 衛教若固定管路之膠帶鬆脫或紗布滲溼，請告知護理人員更換。
- (4) 衛教若有不適症狀（如：頭暈、心悸），請告知護理人員處理。

5. 體液過多/水腫

- (1) 觀察水腫的程度、部位及皮膚狀況。
- (2) 每天測量體重。
- (3) 依醫師指示限制鈉及水分攝取。
- (4) 無發炎情況，如紅腫熱痛，可予適度保暖，如室溫調整、熱敷等，促進血管擴張及循環。
- (5) 保持皮膚的清潔及完整，清除污垢、異味、降低感染機會，可使用中性肥皂清潔後輕拭乾淨，再塗抹乳液。

（八）實施及修訂

本辦法經護理長會議通過後，呈督導會議核准後公布實施，修正時亦同。

四、使用表單

（略）

主題名稱	胰臟癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K26	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	6/7

五、流程圖

(略)

六、參考資料

- (一) 台灣癌症防治網 (2022 年 6 月 28 日)。認識胰臟癌。台灣癌症防治網。
<http://web.tccf.org.tw/lib/project/books/book02.php>
- (二) 李君陽、李重賓(2020)。胰臟癌治療新趨勢。《臨床醫學月刊》，86(2)，505-508。
- (三) 吳麗彬、周繡玲、劉莉妮(2020)。消化系統疾病之護理。於劉雪娥總校閱，*成人內外科護理* (八版，495-498)。華杏。
- (四) 陳偉鵬(2023)。水腫。於陳偉鵬等編著，*臨床症狀護理* (四版)。台北：華杏。
- (五) 張玲綺(2020)。照護一位初次診斷胰臟癌末期病患之護理經驗。《彰化護理》，27(4)，99-110。
- (六) 潘佩儀、蔡惠珠(2020)。照護一位胰臟癌末期病人之護理經驗。《志為護理》，19(3)，109-117。
- (七) 魏于婷、黃惠美、塗勝祥、溫明寰(2021)。一位胰臟癌肝轉移合併惡性腹水病人之臨終照護經驗。《高雄護理雜誌》，38(3)，124-136。
- (八) American Cancer Society (2022, June 28). Pancreatic Cancer. American Cancer Society. <https://www.cancer.org/cancer/pancreatic-cancer.html>
- (九) Carlos F.C. (2022). Clinical manifestations, diagnosis, and staging of exocrine pancreatic cancer. UpToDate.
- (十) Wood, L. D., Canto, M. I., Jaffee, E. M., & Simeone, D. M. (2022). Pancreatic Cancer: Pathogenesis, Screening, Diagnosis, and Treatment. *Gastroenterology*, 163(2), 386–402.e1. <https://doi.org/10.1053/j.gastro.2022.03.056>

七、附件

(略)

主題名稱	胰臟癌	制定單位		護理部	
編號	A31000-Q03-W-K26	版本	第 1.2 版	頁碼/總頁數	7/7

八、文件修正紀錄

修正日期	版本	修正說明	備註
112.02.07	1.0	新制定。	111 年 12 月 14 日護理長會議通過；112 年 02 月 07 日督導會議通過公布。
112.10.26	1.0	年度檢閱，無修正。版本不變動。	
113.12.17	1.1	第三項第四目之 3.新增療法。	113 年 10 月 15 日照護標準組會議通過；113 年 12 月 11 日護理長會議通過；113 年 12 月 17 日督導會議通過公布。
115.01.06	1.2	1.第三項第二目錯字修正。 2.第六項參考資料更新。	114 年 10 月 02 日照護標準組會議通過；114 年 12 月 10 日護理長會議通過；115 年 01 月 06 日督導會議通過公布。